当院における *Staphylococcus* 属菌血液培養陽性症例の起因菌判定とＰＣＲ実施状況

◎荒町 和音[1)]、八島 繁子[1)]、長谷部 雅也[1)]、髙橋 美沙紀[1)]、可児 あかね[1)]、大島 萌楓[1)]、各務 志乃ぶ[1)]、米澤 千佳子[1)]
岐阜県立多治見病院[1)]

【はじめに】*Staphylococcus aureus* 菌血症は様々な合併症を伴う重篤な疾患である。血液培養でグラム陽性ブドウ状球菌が発育した場合、汚染菌/起因菌を迅速に判定し、適切な抗菌薬を選択することが重要である。当院では 2025 年 4 月から AST に感染症医が加わり、血液培養陽性症例の評価を行っている。今回、当院における *Staphylococcus* 属菌検出症例の起因菌判定と PCR 実施状況を報告する。

【方法】2025 年 4 月～2026 年 3 月に血液培養で *Staphylococcus* 属菌が初回検出された 104 件を対象とした。血液培養陽性液から MRSA 関連遺伝子を検出する XpertMRSA/SA BC「セフィエド」（ベックマン・コールター、以下 PCR）を使用した。当院では 24 時間以内に陽性になった入院患者で、平日時間内に陽性報告した場合に PCR を実施し、MRSA、MSSA、*mecA* の結果を報告している。また、医師や薬剤師からの依頼がある場合も実施している。

【結果】104 件中 61 件（58.7%）を起因菌、43 件（41.3%）を汚染菌と判定した。MSSA および MRSA は全て起因菌であった。AST カンファレンスで判定した起因菌のうち 5 件は、J-SIPHE の自動判定基準による判定で汚染菌となった。全て CNS で、1 セットのみ陽性であった。PCR は 37 件で実施し、培養結果との不一致は無かった。37 件中 25 件（67.6%）が起因菌で、内訳は MSSA 17 件、 MRSA 4 件、CNS 4 件であった。12 件（32.4%）は汚染菌で、この菌に対する抗菌薬投与は無かった。25 時間以降に陽性になった 26 件のうち 4 件で依頼を受けて PCR を実施し、3 件が起因菌となった。

【考察】PCR 結果から MRSA を否定できた症例では、早期に狭域抗菌薬を選択できた。汚染菌と判断した症例では不要な抗菌薬投与を避けることができた。実施基準を満たさない症例でも医師や薬剤師からの依頼を受けて PCR を実施し、適切な抗菌薬使用につながった。また、AST カンファレンスで患者の状態や処置内容なども考慮し、自動判定では拾えない起因菌を正しく判定できた。多職種連携により、PCR 検査が有効活用されていると考えられる。

岐阜県立多治見病院―0572-22-5311